চৌগাছা- ঝিনাইদহ (সিজে) জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ

ভূমিকা

জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার, এবং সমাজ, নিজেদের ও সমাজের সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণের দায়িত্ব পালন করে এবং সমাজের স্বাস্থ্য উন্নয়নে অবদান রাখতে সমর্থ হয়। জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় জনগণ নিজস্ব স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নে (১) পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ণে অংশগ্রহণ (২) প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উন্নয়ন, জনবল ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রী সংগ্রহে সহায়তা; এবং (৩) জনসচেতনতা তৈরি এবং স্বাস্থ্য সেবায় যুক্ত হয়ে তা ব্যবহারে সহায়তা করতে পারে।

স্বাস্থ্যসেবার বিভিন্ন দিক হল প্রতিরোধ(Preventive), উন্নীত (Promotive), নিরাময় (Curetive), পুনর্বাসন (Rehabilitative) ও উপশমক (Palliative) কার্যক্রম। এ সকল কার্যক্রম একক ভাবে স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, জনগনের সম্পৃক্ততা অপরিহার্য্য।

জাতিসংঘের অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের ন্যায় বাংলাদেশও আগামী ২০৩২ সালের মধ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর নাগরিকের জন্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সকলের জন্য আর্থিক সুরক্ষাসহ মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ বর্তমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থার নিরিখে চ্যালেঞ্জ হিসাবে প্রতিভাত হতে পারে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রায় ৮০% ভাগ জনসাধারণ সরকারী হাসপাতাল হতে স্বাস্থ্যসেবা নেন না, মাত্র ২৩% প্রসব সরকারী হাসপাতালে হয়ে থাকে; উপজেলা হাসপাতালগুলো অনেকাংশেই অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে। এ সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশের উপজেলা- জেলা সহ বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতালে প্রয়োজনীয় সম্পদের বিনিয়োগ এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা প্রমিতমানে উন্নয়নসহ কাঙ্খিত স্বাস্থ্য সূচক সমূহ অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।

হাসপাতালে ব্যবস্থাপকদের সুযোগ্য নেতৃত্বদান; হাসপাতাল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা; সকল স্বাস্থ্যসেবাদানকারীদের দলবদ্ধভাবে স্বাস্থ্য সেবায় যুক্তকরণ; জনবল, সরঞ্জামাদি, ঔষধপত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য উপকরণের নিয়মিত যোগান; ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠি – বিশেষত: মা ও শিশুবান্ধব স্বাস্থ্য সেবা; স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং সেবা গ্রহণে স্থানীয় জনগণ ও জনপ্রশাসনের সম্পৃক্ততা প্রভৃতি ছাড়া সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না।

বাংলাদেশে সফল টিকাদান কর্মসূচি এবং কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন – সরকারী কার্যক্রমের সাথে জনসম্পৃক্ততার উজ্জ্বল উদাহরণ। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সফল মাইলফলক হল চৌগাছা- ঝিনাইদহ (সি- জে) মডেল। সি- জে মডেল হল উপজেলা- জেলা পর্যায়ের সরকারী স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের এমন একটি স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনা, যা নৈতিক মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে জনকল্যাণে অঙ্গীকারাবদ্ধ দক্ষ ব্যক্তি ও দলের নেতৃত্বে স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় সরকারী সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে। এর পাশাপাশি জনগণের সহযোগিতা নিয়ে স্বল্প সময়ে সরকারী লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার মাধ্যমে জনগণের চাহিদা পূরণ করে। এ মডেল আস্থাশীল সেবা ব্যবস্থাপনা এবং স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় জনগণের অধিকারবোধ প্রতিষ্ঠিত করে। 'চৌগাছা- ঝিনাইদহ (সিজে) জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা' বাংলাদেশের সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় মডেল হিসাবে সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সহ অন্যান্য সংস্থারও আস্থা অর্জন

করেছে। সিজে মডেলের বড় উপাদান হলঃ 'জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে অঙ্গিকারাবদ্ধ নেতৃত্ব', 'জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা' এবং স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের সার্বিক বিষয়ে স্থানীয় 'জনগণের অধিকার বোধ'।

চৌগাছা এবং ঝিনাইদহ এবং অনুরূপ ব্যবস্থাসম্পন্ন আরও কিছু হাসপাতালে জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার মূল রূপকার হিসাবে ভূমিকা পালন করেছে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকদের বিশেষ কিছু গুণাবলী যেমন: নেতৃত্ব, স্বাস্থ্য সেবায় উৎসর্গীকৃত মনোভাব, কর্মস্থলে সার্বক্ষণিক উপস্থিতি, ভাল ব্যবহার, স্বচ্ছ আর্থিক ব্যবস্থাপনা, দলবদ্ধভাবে স্বাস্থ্যসেবা, লক্ষ্য নির্ভর স্বাস্থ্য কর্মসূচী, বিরাজিত সরকারী সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার, প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবে সম্পদ সংগ্রহ করে জনবল- সরঞ্জামাদির ঘাটতি মোকাবেলা, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং জনপ্রশাসনের সাথে সুসম্পর্ক, ইত্যাদি। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ে উদ্ভূত জটিল কোন সমস্যা নিরসনে স্থানীয় জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে দ্রুত সমাধানের উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছে, যা স্বাস্থ্য সেবা গতিশীল রাখতে প্রভূত ভূমিকা পালন করেছে। এ মডেলের আরো একটি উপাদান হচ্ছেঃ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনার উন্নতিকল্পে স্থানীয় জনগণ ও বিত্তবান ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় স্বাস্থ্যসেবা সহায়ক জনবলের যোগান এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা সামগ্রী সরবরাহ করা। পাশাপাশি, সেবাদানকারী ব্যক্তিবর্গের (চিকিৎসক, সেবিকা ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী) নিরাপত্তা বিধান এবং বন্ধুত্বপূর্ণ জনবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে এ সব হাসপাতালে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার এ মডেলে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, জনপ্রশাসন, স্থানীয় চিকিৎসক নেতৃবৃন্দ, আইনজীবী, আইন শৃংখলা বাহিনী, সাংবাদিক, শিক্ষক, বেসরকারী সংস্থা, বিত্তশালী দাতা ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করছেন। এটা সবিশেষ লক্ষণীয় যে, যে সব দেশ সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করেছে সে সব দেশের অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্বাচিত স্থানীয় সরকার সরাসরি স্বাস্থ্য সেবায় সম্পৃক্ত থাকে। আমাদের দেশেও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে। যে সব স্থানে এ মডেল পূর্ণ বা আংশিকভাবে চলমান সেখানে স্থানীয় সম্পদের সমাবেশ সম্ভব হয়েছে এবং সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার মান উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি দূর করা সম্ভব হয়েছে, সর্বোপরি সুশাসন ও জনপ্রশাসনের জনকল্যাণধর্মী উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছে।

এ সমস্ত কার্যক্রম গ্রহণের ফলে চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সেবা গ্রহণের পরিমাণ এবং মান উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শয্যা ব্যবহারের হার ১৯৯৭ সালে ৭৮.৯% হতে ২০১১ সালে ২০৮.০%এ উন্নীত হয়; গর্ভকালীন পরিচর্যা ১৯৯৬ সালে ৮১৭ (১৬.৩%) হতে ২০১১ সালে প্রথম ভিজিট ৮৯৩৫ (১৭০%)এ উন্নীত হয়; হাসপাতালে প্রসব ১৯৯৬ সালে ৯৯ (২.১) হতে ২০১১ সালে ৪৪১৩(৯৮.৪%) এ উন্নীত হয়; প্রয়োজনীয় সিজারিয়ান সংখ্যা ১৯৯৬ সালে ১ (.০২%) হতে ২০১১ সালে ১০০৭ (২২.৫%) এ উন্নীত হয়। সিজে জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা চৌগাছা উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সূচকেও অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছে: ১৯৯৫ সালে মাতৃমৃত্যু হার ১ লক্ষ জীবিত জন্মে ৫৯৯ হতে ২০১১ সালে ৬৮ তে নামিয়ে এনেছে, নবজাতক এবং অনুর্ধ ৫ বছরের শিশু মৃত্যু ১৯৯৫ সালে যথাক্রমে ৪২ ও ৭৮ হতে ২০১১ সালে ১৮.২ ও ২৩.৬ এ নেমেছে। ২০১৭ সালের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, নানা কারণে এ অগ্রগতি কিছুটা শ্লথ হলেও এখনও তা অন্যান্য উপজেলাগুলোর চেয়ে উল্লেখযোগ্য ভাবে শ্রেয়তর।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালেও সিজে মডেল জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা মডেল বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহণকারী রোগীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে; ১৯৯৮ সালে বহিঃবিভাগ ও জরুরী বিভাগে রোগীর সংখ্যা ৮১,৭৯৫ জন হতে ২০১৭ সালে ৩৪০,৯৩২ জন এবং অন্ত:বিভাগে তা ১২, ৯৭৩ হতে বেড়ে ২০১৭

সালে ৩৫, ৫৬৯ জনে পৌঁছায়। শয্যায় অবস্থানের হার ১২৬% হতে ২৪২% এবং প্রসবের সংখ্যা ১,১০৬ হতে ২,৯৯৭এ পৌঁছায়। খুলনা বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালের মধ্যে চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল প্রসব সেবায় যথাক্রমে ২০১১ এবং ২০১৭ সালে প্রথম স্থান অধিকার করে। প্রতিষ্ঠান দুটিকে বহুবার জাতীয় পুরষ্কার দেওয়া হয়েছে। চৌগাছা স্বাস্থ্য কম্প্লেক্স ২০১৭ এবং ২০১৮ সালেও বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ উপজেলা স্বাস্থ্যকম্প্লেক্স হিসেবে "স্বাস্থ্যমন্ত্রী" পুরষ্কার লাভ করে।
উপরোক্ত দুই হাসপাতাল এবং দেশের আরও কিছু সংখ্যক হাসপাতাল অনুরূপ ব্যবস্থাপনায় সরকার হতে অতিরিক্ত কোন বরাদ্দ ছাড়াই সেবার পরিমাণ, গুণগতমান এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়েছে। দেশে সরকারী হাসপাতালগুলোর সেবার পরিধি ও মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে চৌগাছা-ঝিনাইদহ (সি- জে) জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা মডেল অনুকরণীয় হতে পারে। এ উদাহরণকে সামনে রেখে সরকার তাই সুনির্দিষ্ট সময়সীমা ও লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেশের সকল সরকারী স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট মানদন্ডের ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ করে পর্যায়ক্রমে সি- জে মডেল জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা মডেল সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

চৌগাছা- ঝিনাইদহ (সিজে) জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় সফল নেতৃত্ব
২. স্বাস্থ্য সেবাদানে ব্যক্তিগত ও দলগত দক্ষতা
৩. স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় জনসম্পৃক্ততা
৪. সরকারী সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার
৫. জনপ্রশাসনসহ অন্যান্য সরকারী সংস্থাসমূহের সাথে কার্যকর সমন্বয়
৬. জনসম্পৃক্ততায় সুরক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি
৭. উন্নত মাতৃ স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম
৮. উন্নত শিশু স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম
৯. বিষয়ভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ
১০. জন্ম- মৃত্যু সহ সকল স্বাস্থ্য সূচকের তথ্য সংগ্রহপূর্বক অগ্রগতি মূল্যায়ন ও দায়বদ্ধতা সৃষ্টি
১১. স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতনতা তৈরি করা
১২. প্রাতিষ্ঠানিক পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা (বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) ও সৌন্দর্যবর্ধন
১৩. জরুরি প্রয়োজনে নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালনের ব্যবস্থা
১৪. দূর্নীতি প্রতিরোধে শূন্য সহিষ্ণুতা প্রদর্শন
১৫. স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে "৫এস কাইজেন- টিকিউএম" বাস্তবায়ন
১৬. ইউনিট ব্যবস্থাপনায় স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন

রূপকল্প (Vision)

বাংলাদেশে স্বাস্থ্যবান জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা

ব্রত (Mission)

২০৩২ সাল নাগাদ বাংলাদেশের সকল নাগরিকের জন্য সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা

লক্ষ্য (Goal)

বাংলাদেশের সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও জেলা সদর হাসপাতালে ২০২২ সাল নাগাদ স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে সি- জে জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা মডেলের সম্প্রসারণ

সম্প্রসারণের লক্ষ্যমাত্রা

জুন ২০২০ সাল নাগাদ – ৪০ উপজেলা ও ২০ জেলা;
জুন ২০২১ সাল নাগাদ – আরো ২৫০ উপজেলা ও ৩৫ জেলা;
জুন ২০২২ সাল নাগাদ – অবশিষ্ট সকল উপজেলা ও জেলা।

উদ্দেশ্য (Objectives)

১. বাংলাদেশ সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার স্বাস্থ্য উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সবর্জনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে স্থানীয় পর্যায়ে পদক্ষেপ গ্রহণ
২. সরকারি পর্যায়ে বরাদ্দকৃত সম্পদ ও সুযোগ- সুবিধার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ
৩. স্থানীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ও বহুমুখী অবদানের সুযোগ সৃষ্টি
৪. নেতৃত্বগুণের বিকাশ ও উদ্বুদ্ধকরণ
৫. বিষয়ভিত্তিক সেবার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন
৬. নানাবিধ কমিটি গঠনের মাধ্যমে দলগত কর্মকৌশলে স্থানীয় পর্যায়ে সরকারের স্বাস্থ্যসেবা পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পরিচালন ও পর্যবেক্ষণ
৭. নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মুল্যায়ন এর মাধ্যমে ধারাবাহিক সফলতা, উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা

উপসংহার

স্বাস্থ্যসেবা একটি বহুমাত্রিক মানবিক ব্যবস্থা। মানুষের রোগ প্রতিরোধ, নিরাময়, স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পুনর্বাসন একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ। সরকারের একার পক্ষে তা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তাই জনসম্পৃক্ততা অপরিহার্য। চৌগাছা- ঝিনাইদহ মডেল জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। এ ব্যবস্থাপনা চালুর মাধ্যমে সে সব স্থানে জনগণের আস্থা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। এ ব্যবস্থায় জনগণ স্বাস্থ্যসেবা, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ পেয়েছে। জনসম্পৃক্ততার ফলে ভবিষ্যতে তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে স্বাস্থ্য সেবায় সমস্যাসমমূহ চিহ্নিত করা ও সমাধানে ভূমিকা রাখা সহজ হবে। বাংলাদেশে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ঘোষিত "সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা" কার্যক্রম বাস্তবায়নে এ মডেল অনেকখানি ভূমিকা রাখবে।

ঝিনাইদহ- চৌগাছা'র কাছাকাছি যে সব জেলা সদর হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

৪০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

ক্রমিক নং	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	জেলা	বিভাগ
১.	লালমোহন	ভোলা	বরিশাল

ক্রমিক নং	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	জেলা	বিভাগ
২.	মনপুরা	ভোলা	
৩.	মুলাদী	বরিশাল	
৪.	উজিরপুর	বরিশাল	
৫.	বাউফল	পটুয়াখালী	
৬.	পেকুয়া	কক্সবাজার	চট্টগ্রাম
৭.	চাটখিল	নোয়াখালী	
৮.	ফটিকছড়ি	চট্টগ্রাম	
৯.	সাটুরিয়া	মানিকগঞ্জ	ঢাকা
১০.	সাভার	ঢাকা	
১১.	কালুখালি	রাজবাড়ি	
১২.	ফকিরহাট	বাগেরহাট	খুলনা
১৩.	শ্যামনগর	সাতক্ষীরা	
১৪.	কেশবপুর	যশোর	
১৫.	অভয়নগর		
১৬.	ঝিকরগাছা		
১৭.	শার্শা		
১৮.	মনিরামপুর		
১৯.	বাঘারপাড়া		
২০.	কোটচাঁদপুর	ঝিনাইদহ	
২১.	মুজিবনগর	মেহেরপুর	
২২.	কুমারখালী	কুষ্টিয়া	
২৩.	নকলা	শেরপুর	ময়মনসিংহ
২৪.	মেলান্দহ	জামালপুর	
২৫.	মোহনগঞ্জ	নেত্রকোনা	
২৬.	কালাই	জয়পুরহাট	রাজশাহী
২৭.	ঈশ্বরদী	পাবনা	
২৮.	চৌহালী	সিরাজগঞ্জ	
২৯.	শিবগঞ্জ	বগুড়া	
৩০.	শিবগঞ্জ	চাঁপাইনওয়াবগঞ্জ	
৩১.	পীরগঞ্জ	রংপুর	রংপুর
৩২.	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা	
৩৩.	বীরগঞ্জ	দিনাজপুর	
৩৪.	চিরিরবন্দর	দিনাজপুর	
৩৫.	খানসামা	দিনাজপুর	
৩৬.	উলিপুর	কুড়িগ্রাম	
৩৭.	গোলাপগঞ্জ	সিলেট	সিলেট
৩৮.	বিয়ানীবাজার	সিলেট	
৩৯.	মাধবপুর	হবিগঞ্জ	
৪০.	কুলাউড়া	মৌলভীবাজার	

চলমান

ঝিনাইদহ- চৌগাছা'র কাছাকাছি যে সব জেলা সদর হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

২০টি জেলা হাসপাতাল

ক্রমিক নং	জেলা হাসপাতাল	বিভাগ
১.	ভোলা	বরিশাল

২.	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম
৩.	কক্সবাজার	
৪.	বান্দরবন	
৫.	খাগড়াছড়ি	
৬.	লক্ষ্মীপুর	
৭.	চাঁদপুর (২৫০ শয্যা)	
৮.	মানিকগঞ্জ (২৫০ শয্যা)	ঢাকা
৯.	নরসিংদী	
১০.	যশোর	খুলনা
১১.	নড়াইল	
১২.	চুয়াডাঙ্গা	
১৩.	টাঙ্গাইল	ময়মনসিংহ
১৪.	জামালপুর	
১৫.	জয়পুরহাট (২৫০ শয্যা)	রাজশাহী
১৬.	সিরাজগঞ্জ	
১৭.	নাটোর	
১৮.	ঠাকুরগাঁ	রংপুর
১৯.	কুড়িগ্রাম	
২০.	হবিগঞ্জ	সিলেট